Connaissances et attitudes du personnel sur les risques cliniques en néonatologie au centre hospitalier universitaire de Tengandogo

Nom du présentateur : Aristide A. K. DJIGUIMDE

Auteurs et coauteurs : **So A 2 , Kafando K 3 , Nana F 2 , Yameogo/Zoungrana N 4 , Bocoum YAYA F 2, Hien H 2 , Dao L 1 , Drabo KM 2**

Affiliations : 1.Département mère-enfant du CHU Tengandogo 2.Département biomédical/Santé publique Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) 3.Direction de la qualité CHU-T 4.Département de santé publique du CHU Tengandogo

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Le nouveau-né fragilité / certains sont amenés à séjourner en néonatologie sont exposés à de nombreux risques

- Les risques soumis par les Nnés: IAS (7,5 à 12,7 %), l'utilisation de médicaments (5 %), prolongation séjour, décès…

- la pathologie néonatale représente **1,7% des 10 principaux motifs d'hospitalisation** dans les centres médicaux et hôpitaux du pays); 13,5% des décès hospitaliers (MSHP, 2024)

Objectif

- Evaluer les connaissances et attitudes du personnel sur les risques liés aux activités cliniques dans l'unité de néonatologie au CHU-T (OG)
- Apprécier les connaissances du personnel sur les risques cliniques dans l'unité de néonatologie (OS1)
- Identifier les attitudes du personnel face aux risques cliniques en néonatologie (OS2)

Matériel et méthode(s)

- Etude transversale à visée descriptive
- Cadre Et. : unité de néonatologie (4 couveuses et 16 berceaux)
- Population étudiée: 22 Professionnels de santé (1 ISO, 9 IDE, 5 IB, 4 Pédiatres)
- Techniques et instruments de collecte des données: L' enquête (questionnaire AD)

Matériel et méthode(s)

Variables en rapport avec les connaissances	Variables en rapport avec les attitudes
1. Définition du risque	1. Comportement face au risque
2. Définition de la source de risque	2. Comportement face à la source du risque
3. Identification des types de risques	
4. Identification des sources de risque	

Les réponses appréciées selon deux indices du score (Bon / insuffisant)
selon une Echelle de ESI & Njoya < 25% de bonnes réponses = Mauvais [25% 50%[de bonnes réponses = Insuffisant [50% 70%[de bonnes réponses = Moyen
≥ 70% de bonnes réponses = Bon

Résultats

Caractéristiques socioprofessionnelles des enquêtes de l'unité de néonatologie

Qualification	Effectif
Pédiatre	4
Attaché de santé en pédiatrie (ISOP)	1
Infirmière diplômée d'Etat	12
Aides-soignantes	5
Total	22

Ancienneté au poste des prestataires	Effectif
<1 an	0
1 an à 5 ans	11
6 ans à 10 ans	7
> 10 ans	4
Total	22

Résultats

- Niveaux de connaissance sur le risque: 77% (bon niveau).

- Niveaux de connaissance (moyens) les sources du risque: prescription médicamenteuses (68%); remplissage des supports de surveillances (68%); sortie des nouveau-nés (59%).

- Types de risques cités : IAAct (32%) erreurs médic. (prescriptions, adm) (23%), Fausses routes A. (13%), Hémorragie au point d'injection (13%), Atteinte visuelle et/ou génitale/ photothérapie (13%),

Résultats

- Bonnes attitudes face aux sources du risque :

la transfusion de produits sanguins labiles (91%), le bain du nouveau-né (86%), l'administration des traitements aux patients (82%), la visite des parents (73%).

- attitudes insuffisantes face aux sources de risques : utilisation EPI, nutrition entérale, certaines instructions tech

Conclusion

- Le personnel : production des soins avaient de bonnes connaissances sur les risques.
- Des attitudes identifiées (EPI, la nutrition entérale, des instructions tech.)
- Sensibilisation/ supervision nécessaires pour accroitre /maintien des connaissances/ attitudes à l'égard du risque hospitalier.

Merci pour votre attention